



MANEJO DA DISPEPSIA E REFLUXO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Iolanda Felipe da Silva Bona
Médica de Família e Comunidade
IESCVI



OBJETIVOS:

1. Caracterizar a dispepsia e seus tipos.
2. Compreender a avaliação clínica e o manejo da dispepsia.
3. Conhecer os exames complementares, tratamentos e prognóstico para dispepsia.

Caso clínico

Judite, 49 anos, é usuária frequente do serviço de saúde devido a dores osteomusculares: diz estar habituada com elas, as relaciona ao trabalho de diarista, e costuma comprar por sua conta o remédio na farmácia, do qual não se lembra do nome. Hoje, vem à consulta porque está preocupada com uma nova dor, agora no “estômago”, que melhora quando come algo. Sente-se empachada durante todo o dia, “como se tivesse algo dentro”. Isso lhe preocupa particularmente, já que o irmão de sua patroa faleceu de câncer gástrico, motivo pelo qual a patroa lhe recomendou procurar logo um médico para fazer uma endoscopia. Chegou a vomitar duas vezes, e as fezes estão com aspecto habitual. Nega emagrecimento, acha até que engordou depois que parou de fumar, há 1 ano. Tem tido dificuldade para dormir, preocupada com o marido que demora a chegar depois das “noitadas” no bar. Como antecedente, realizou laqueadura há 20 anos.

DISPEPSIA

- Conhecida popularmente como “má digestão”.
- É caracterizada pela presença recorrente ou persistente de dor ou desconforto epigástrico não relacionado ao uso de anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) e acompanhado, ou não, de sensação de saciedade precoce, náuseas, vômitos, pirose, regurgitação e excessiva eructação.
- Pode ser classificada em dismotilidade, úlcera ou refluxo.



Quadro 166.1 | Tipos de dispepsia

Dismotilidade

- ▶ Vômitos 1x/mês ou mais
- ▶ Distensão abdominal
- ▶ Dor agravada por alimentação
- ▶ Dor aliviada por eructações
- ▶ Anorexia

Úlcera

- ▶ Dor aliviada por alimentação
- ▶ Dor aliviada por antiácidos
- ▶ Dor antes da alimentação
- ▶ Dor noturna que faz despertar

Refluxo

- ▶ Pirose 1x/semana ou mais
- ▶ Regurgitação ácida 1x/semana ou mais

- A prevalência de sintomas dispépticos na população adulta é de 44% no Brasil.
- Entretanto, a maioria não procura o serviço de saúde: a dispepsia é responsável por 1% dos atendimentos na APS, mas, com frequência, surge como queixa secundária na prática clínica, podendo ser banalizada e medicalizada em excesso.
- Na prática da APS, a maioria dos indivíduos com sintomas dispépticos são tratados como tendo dispepsia não investigada, e sua causa é desconhecida.

- Como diagnósticos etiológicos possíveis, têm-se dispepsia funcional, úlcera péptica, doença do refluxo gastroesofágico e, mais raramente, câncer.
- A dispepsia funcional é responsável por 60% dos casos, sendo caracterizada por sintomas presentes por pelo menos 3 meses e ausência de alterações estruturais.
- A bactéria *Helicobacter pylori* está associada à patogênese da úlcera péptica.
 - ❑ No Brasil, a prevalência da infecção varia de 62 a 81%, ao passo que, em outros países, como os EUA, não chega a 15% da população.

TABELA 82.2 → Critérios do Consenso ROME III para dispepsia funcional

1. Um ou mais dos sintomas abaixo presentes pelos últimos três meses com início de sintoma pelo menos seis meses antes do diagnóstico:³⁷

a) estufamento pós-prandial desconfortável

b) saciedade precoce

c) dor epigástrica

d) queimação epigástrica

e

2. Nenhuma evidência de doença estrutural (após endoscopia alta) que possivelmente explique os sintomas.



ANAMNESE

- A história deve ser dirigida para a detecção de sinais de alerta e a presença de sintomas que sugiram diagnósticos diferenciais à síndrome dispéptica, como problemas cardíacos ou biliares.

Quadro 166.3 | Sinais de alerta e indicações para endoscopia digestiva alta

Imediato

- ▶ Sangramento gastrointestinal significativo

Abordagem inicial – eletiva

- ▶ Disfagia progressiva
- ▶ Perda de peso involuntária
- ▶ Massa epigástrica
- ▶ Anemia ferropriva
- ▶ Vômitos persistentes
- ▶ Persistência dos sintomas após tratamento empírico com IBP e erradicação de *H. pylori*

- É importante definir, também, a frequência dos sintomas e a correlação com hábitos como comer demasiadamente, ingestão de bebidas alcoólicas ou alimentos específicos e tabagismo, uma vez que sintomatologia eventual é comum e não necessita de tratamento medicamentoso prolongado.
- Alguns medicamentos são responsáveis por sintomas dispépticos, seu uso devendo ser averiguado: anti-inflamatórios não esteroides (AINE), antagonistas do cálcio, bifosfonados, biguanidas, corticoides, nitratos e teofilina.
- Aproximadamente 25% daqueles que sofrem de dispepsia procuram por atendimento médico, e a grande maioria deles já apresentava sintomas e se automedicou.

EXAME FÍSICO

- Geralmente, o exame físico é normal ou com uma dor discreta na região epigástrica.
- A presença de massa abdominal pode ser indicativa de malignidade e deve ser investigada.



EXAMES COMPLEMENTARES

- A EDA é o padrão-ouro para o diagnóstico de lesões estruturais e consequentemente de causas específicas da dispepsia.
- Realizar investigação endoscópica como primeira escolha de cuidado em pessoas sem sinais de alerta demonstrou uma discreta redução de recidivas dos sintomas.
 - ❑ Entretanto, o custo do exame, a dificuldade de acesso e os riscos superam os benefícios.
 - ❑ Está indicada na abordagem inicial apenas naqueles que apresentarem sinais de alerta para a exclusão de doença orgânica grave.



- Deverá ser suspenso o uso de IBP e antagonistas H₂ duas semanas antes da realização do exame, pois esses medicamentos podem diminuir a sensibilidade para detecção do *H. pylori*.
- Para identificar infecção pelo *H. pylori* sem realização de EDA, as técnicas mais utilizadas são o teste respiratório com ¹³C ureia e o exame sorológico.
 - ❑ O primeiro apresenta sensibilidade de 88 a 95% e especificidade de 95 a 100%, sendo incomuns resultados falso-positivos.
 - ❑ A sorologia detecta anticorpos IgG específicos para *H. pylori*. É um exame mais sensível (90-100%) e de menor custo, mas permanecerá positivo mesmo após a erradicação da bactéria.

TRATAMENTO

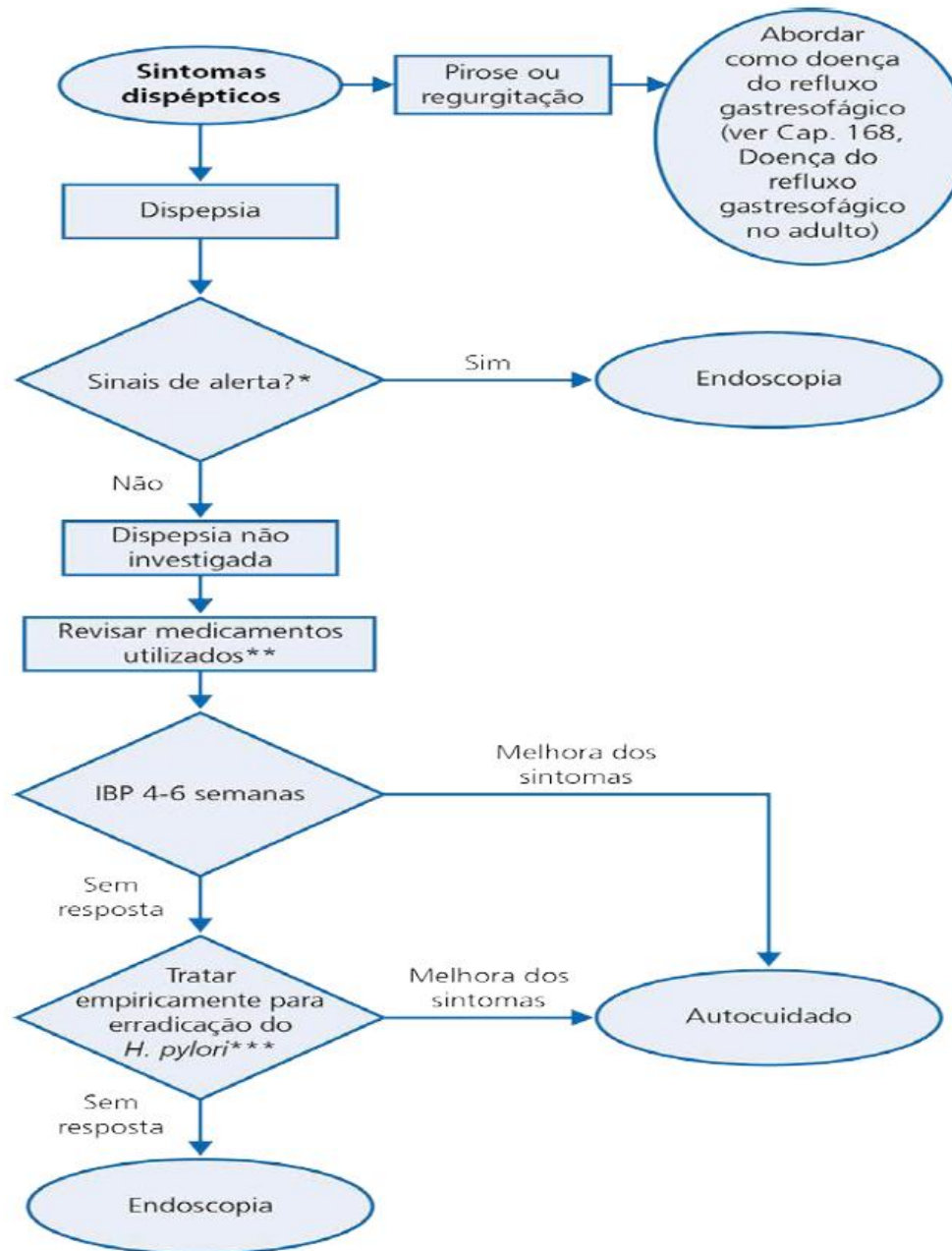
- O tratamento não farmacológico consiste em oferecer simples orientações de mudança de estilo de vida, incluindo alimentação saudável, controle de peso e suspensão do tabagismo, bem como evitar desencadeantes associados a dispepsia e ingestão alimentar em grandes quantidades.
- Deve-se suspender anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), se possível.
- Psicoterapias podem reduzir sintomas dispépticos, porém devido ao seu custo financeiro e de tempo, tais intervenções são pouco utilizadas.

- Em termos de tratamento farmacológico, o autotratamento com antiácidos sob demanda (p. ex., com hidróxido de magnésio + hidróxido de alumínio até seis colheres de sopa por dia) pode ser suficiente para muitos pacientes.
- Entretanto, terapia adicional é apropriada quando os sintomas persistem afetando a qualidade de vida.
- A estratégia inicial na dispepsia não investigada é o tratamento empírico com IBPs, que apresentou melhor resposta e custo-efetividade quando comparado aos antagonistas H₂ e antiácidos.

- “Testar e tratar” a infecção por *H. pylori* é mais efetivo do que a realização de EDA e reduz riscos e custos.
 - ❑ É a estratégia recomendada pelo National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) após falha terapêutica do IBP na dispepsia não investigada.
- Há evidências de que a erradicação da bactéria aumenta a taxa de melhora dos sintomas e/ou diminui a sua recorrência nas principais causas de dispepsia.
 - ❑ Contudo, os exames para detecção da infecção pelo *H. pylori* ainda são pouco disponíveis.
- Dada a alta prevalência da infecção no Brasil, com uma probabilidade pré-teste elevada, uma segunda alternativa seria tratar empiricamente para a erradicação de *H. pylori* após falha terapêutica do IBP.

- A primeira escolha para erradicação de *Helicobacter* são os IBPs duas vezes ao dia + amoxicilina 1.000 mg duas vezes ao dia + claritromicina 500 mg duas vezes ao dia por 14 dias.
- Substituindo-se amoxicilina por metronidazol 500 mg 2x/dia em caso de alergia à amoxicilina e reduzindo-se claritromicina para 250 mg 2x/dia.





PROGNÓSTICO

- A dispepsia é uma condição recorrente e intermitente.
- Estima-se que 50% daqueles que fizeram tratamento adequado terão recidiva de sintomas em 1 ano, e até 80% terão recidiva em algum momento da vida.

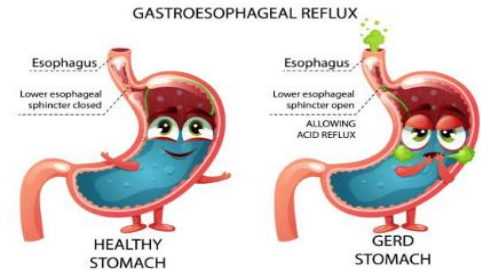
Caso clínico (parte 1)

André, 41 anos, branco, solteiro, professor de educação física há 15 anos, queixa-se de tosse contínua, sem secreção, associada à dor no peito e queimação, que pioram mais à noite, quando acorda subitamente com sensação de dispneia. Os sintomas vêm piorando há 4 meses, após um período de preparação para uma competição de fisiculturismo. Antes da atual consulta, procurou um médico pneumologista, que solicitou uma radiografia torácica (que não apresentou alterações), e receitou-lhe um anti-histamínico, que causou muita sonolência. Não houve melhora do quadro. André relata que, na noite anterior, após ter participado de um churrasco e comido mais do que o habitual, acordou de repente no meio da madrugada, novamente, com sensação de sufocamento, e teve medo de estar tendo um infarto.

Caso clínico – 1a consulta (parte 2)

André relatou que está desesperado e quer algum medicamento paliativo e também alguns exames do coração, pois tem convicção de que tem uma doença cardíaca, apesar de não haver um motivo especial para esse medo ou risco para doença cardiovascular. Ingere três a quatro refeições diárias e não toma refrigerante. Toma um “cafezinho”, três a quatro vezes ao dia, na cantina da academia onde trabalha. Ao exame físico geral, mostra-se em bom estado geral, eupneico, normocorado, afebril, acianótico, anictérico, hidratado. Tem diurese e evacuações normais. Nega melena ou enterorragia. Sistema respiratório: murmúrio vesicular normal, ritmo normal, sem ruídos adventícios. Sistema cardiovascular: ritmo cardíaco regular, bulhas normofonéticas, ausência de sopros, frequência cardíaca de 70 bpm e pressão arterial (deitado) de 120/70 mmHg. Abdome: dor intensa à palpação profunda do epigástrio. Cavidade oral: sem alterações.

REFLUXO



- O refluxo de conteúdo gastroduodenal para o esôfago ocorre de modo fisiológico em pequeno volume, principalmente após as refeições.
- Quando o refluxo passa a causar sintomas (como pirose e/ou regurgitação) frequentes e/ou complicações, torna-se uma doença – a doença do refluxo gastresofágico (DRGE).
- Afecção crônica, decorrente do fluxo retrógrado de parte do conteúdo gastroduodenal para o esôfago e/ou órgãos adjacentes a ele, acarretando um espectro variável de sintomas e/ou sinais esofagianos e/ou extraesofagianos, associados ou não a lesões teciduais.

- Tem impacto negativo na qualidade de vida, aumenta os custos com saúde e o risco para adenocarcinoma do esôfago.
- A ineficácia do mecanismo de barreira na junção esofagogástrica é o principal fator patogênico do RGE. As teorias dominantes para explicá-la são:
 - ❑ Relaxamento transitório do esfíncter esofágico inferior (EEI) sem anormalidade anatômica concomitante;
 - ❑ Alteração anatômica da junção esofagogástrica, provavelmente associada à hérnia hiatal;
 - ❑ Hipotonia do EEI, sem alteração anatômica associada.
- Há registros de casos de RGE nos quais um desses mecanismos é o preponderante. Contudo, desconhece-se a importância de cada um deles no universo de pessoas com RGE.

- A gravidade da lesão da mucosa esofágica é determinada pelo tempo que o esôfago fica exposto ao ácido e pelo pH do material refluído do estômago.
- As pessoas apresentarão sintomas do RGE quando o balanço entre os fatores agressivos (refluxo de material do estômago e o pH desse material) e os fatores defensivos (clareamento do esôfago e resistência da mucosa) for favorável aos primeiros.
- Os portadores da DRGE podem apresentar complicações, tais como esofagites, esôfago de Barrett (EB), estenose péptica e hemorragia.

- A mais importante delas é o EB, por sua predisposição em progredir para adenocarcinoma.
 - ❑ Acomete 10 a 15% dos refluídos crônicos e consiste na substituição do epitélio escamoso esofágico, em geral de sua posição distal, por epitélio colunar glandular contendo células calciformes.
- Outra complicação grave é a estenose péptica, sendo mais frequente naqueles com esofagite grave, cursando com disfagia decorrente da obstrução esofágica.
- A hemorragia é a complicação menos frequente, sendo provocada pelas úlceras esofagianas.





ANAMNESE

- A história clínica deve ser voltada para as principais manifestações clínicas típicas da DRGE, que são a pirose e a regurgitação ácida.
- A duração e a frequência dos sintomas são informações importantes que precisam ser sempre avaliadas e quantificadas.
 - ❑ Sintomas com frequência mínima de duas vezes por semana, há cerca de 4 a 8 semanas, sugerem DRGE.
- A ausência de sintomas típicos não exclui o diagnóstico, uma vez que outras manifestações têm sido descritas como manifestações atípicas:
 - ❑ Esofagianas: dor torácica não cardíaca.
 - ❑ Pulmonares: asma, tosse crônica, hemoptise, bronquite, bronquiectasia e pneumonias de repetição.
 - ❑ Otorrinolaringológicas: rouquidão, pigarro, laringite posterior crônica, sinusite crônica, otalgia.
 - ❑ Orais: desgaste do esmalte dentário, halitose e aftas.

EXAMES COMPLEMENTARES

- Na grande maioria dos casos, a investigação complementar deve ser solicitada nas seguintes condições:
 - ❑ Ausência de resposta ao tratamento.
 - ❑ Manifestações de alarme: disfagia, odinofagia, anemia, hemorragia digestiva e emagrecimento, história familiar de câncer, náuseas e vômitos, dor torácica, além de sintomas de grande intensidade e/ou de ocorrência noturna.
 - ❑ Sintomas crônicos (lembrar-se da possibilidade de EB).
 - ❑ Necessidade de tratamento continuado.

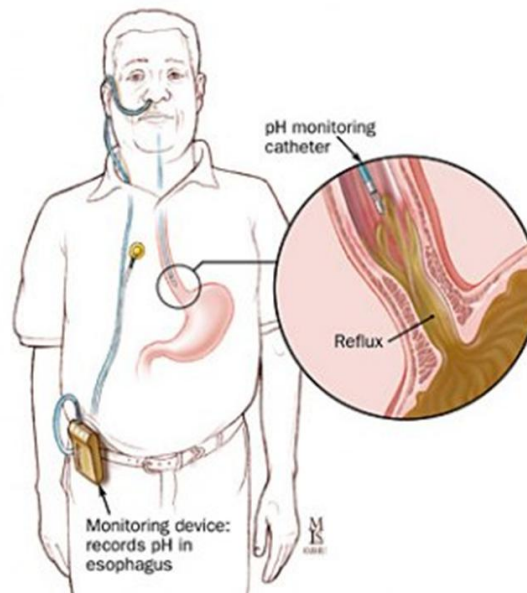
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E BIÓPSIA

- A EDA é o método mais comumente utilizado para avaliar pessoas com RGE.
- O exame endoscópico, embora apresente uma sensibilidade de cerca de 60%, pela facilidade de sua execução e sua disponibilidade em centros médicos, é o método de escolha para o diagnóstico das lesões causadas pelo RGE.
- Sendo um exame essencialmente morfológico, identifica as alterações causadas pelo refluxo, presença de hérnia hiatal ou exclui outras enfermidades.
- Possibilita realizar biópsia da mucosa, imprescindível para o diagnóstico de EB.
- Deve-se ressaltar que a ausência de alterações endoscópicas não exclui o diagnóstico de DRGE, já que 25 a 40% das pessoas com sintomas típicos apresentam endoscopia normal.

PHMETRIA PROLONGADA DE 24 HORAS

- Monitora por 24 horas o pH intraesofágico, considerando-se haver RGE quando ocorrer queda do pH abaixo de 4.
- Embora considerada como padrão-ouro para o diagnóstico da DRGE, é sujeita a críticas, pois tem demonstrado haver variações significativas na sensibilidade do método.
 - ❑ Ainda assim, trata-se do melhor procedimento para caracterizar RGE.
- Por meio da avaliação pHmétrica, é possível quantificar a intensidade da exposição da mucosa esofágica ao ácido.
 - ❑ Permite também que efetivamente se estabeleça a correlação entre os sintomas relatados pela pessoa e os episódios de refluxo.

- Indica-se a realização do exame de pHmetria de 24 horas para:
 - ❑ Pessoas com sintomas típicos de DRGE que não apresentam resposta satisfatória ao tratamento com inibidor da bomba de prótons (IBP) e nos quais o exame endoscópico não revelou dano à mucosa esofágica.
 - ❖ Nesses casos, o exame deve ser realizado na vigência da medicação.
 - ❑ Pessoas com manifestações atípicas extraesofágicas sem presença de esofagite.



ESOFAGOMANOMETRIA

- É o registro das pressões geradas no interior do esôfago.
- Não tem papel diagnóstico no RGE, mas é utilizada para avaliar a peristalse e a competência do EEI.

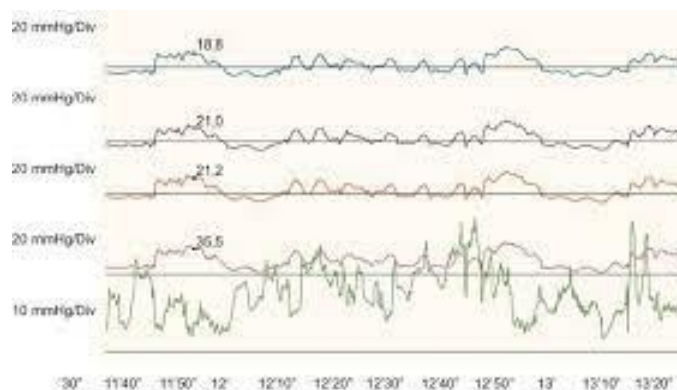
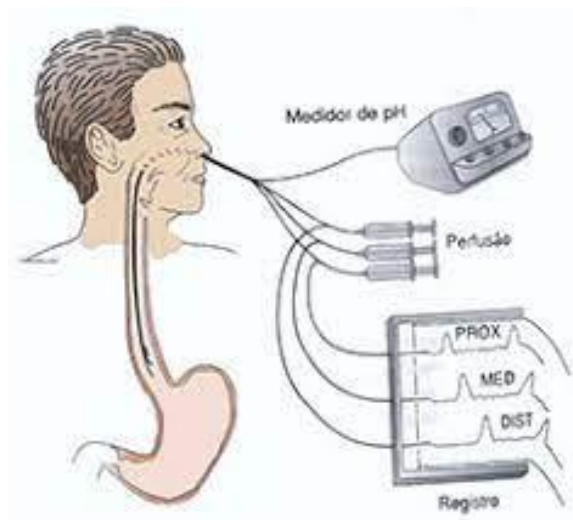


Figura 85.22 Esfagomanometria de paciente com **acalasia**. No canal distal (PS), o EEI com relaxamentos incompletos. Nos quatro canais proximais (P1-P4), aperistalse do corpo esofágico (distância de 5 cm entre os canais).

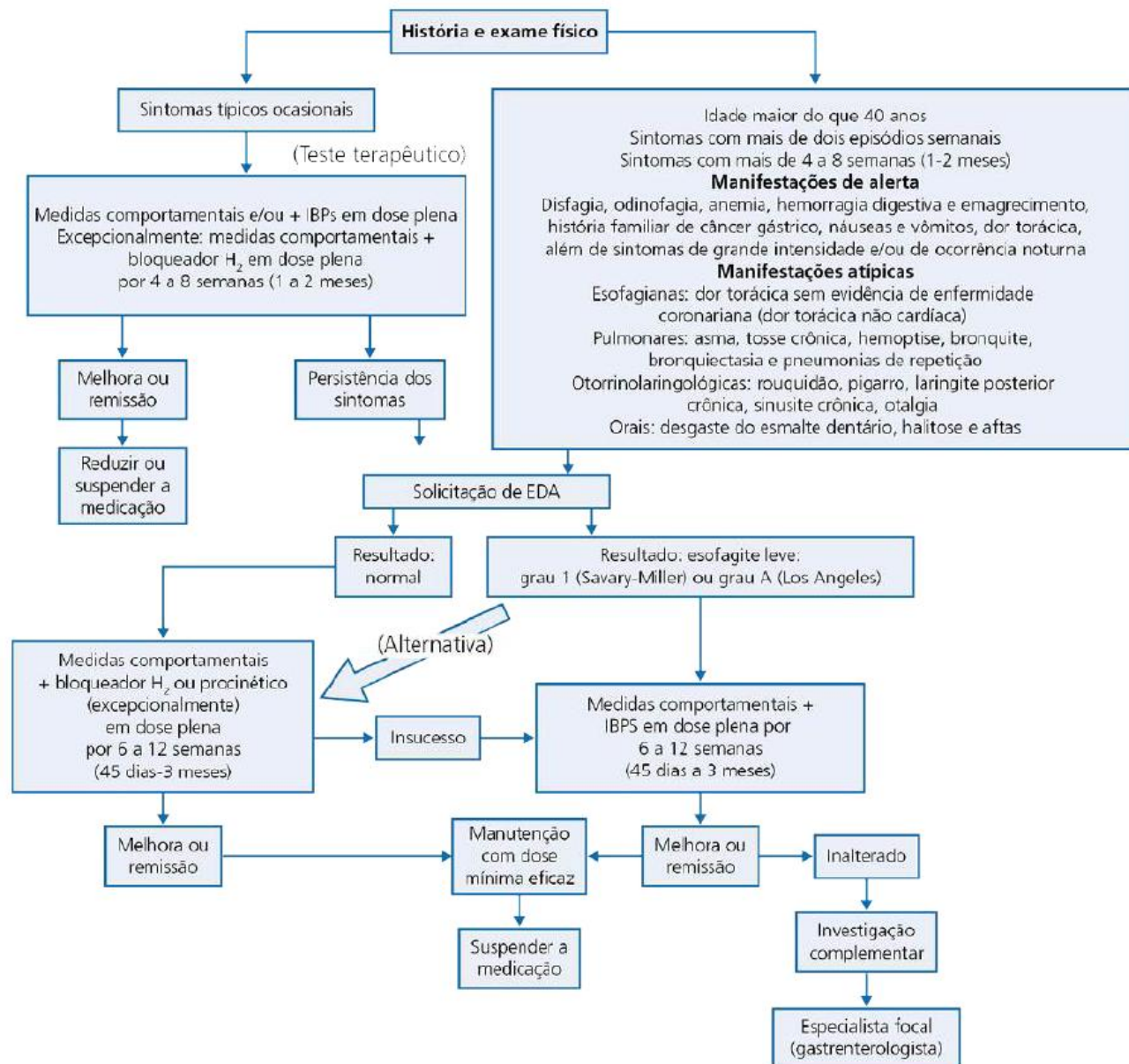
EXAME RADIOLÓGICO CONTRASTADO DO ESÔFAGO

- Embora seja muito difundido e apresente custo relativamente baixo, não está indicado na rotina de investigação da DRGE, pois apresenta baixa sensibilidade, em particular nos casos de esofagite leve.
- As principais informações que o exame radiológico pode oferecer se referem à avaliação da anatomia esofágica, como nas lesões estenosantes do esôfago, e alterações motoras pelo achado de ondas terciárias e espasmos do órgão.
- A indicação do método radiológico no diagnóstico da DRGE está restrita ao esclarecimento do significado da disfagia e da odinofagia.



TRATAMENTO

- Com propósitos práticos, pode-se dividir a abordagem terapêutica em medidas comportamentais e farmacológicas, que deverão ser implementadas concomitantemente em todas as fases da enfermidade.
- É fundamental que a pessoa saiba que é portadora de uma enfermidade crônica e que haja parceria com o médico para que as medidas possam ser adotadas, sobretudo as comportamentais.
- Em pessoas que referem pirose e/ou regurgitação como sintomas predominantes ou únicos, não é necessário fazer investigação complementar, ao menos em um primeiro momento, devendo ser tratadas empiricamente.
 - ❑ Se responderem ao tratamento, assume-se que tenham RGE.



Quadro 168.1 | Medidas comportamentais no tratamento do refluxo gastresofágico

- ▶ Instruir a pessoa sobre RGE, por meio do método clínico centrado na pessoa, fornecendo-lhe material informativo/ilustrativo de acordo com a realidade local do atendimento.
- ▶ Elevar a cabeceira da cama (15 cm).
- ▶ Moderar a ingestão dos seguintes alimentos, dependendo da correlação com os sintomas: gordurosos, cítricos, café, bebidas alcoólicas, bebidas gasosas, menta, hortelã, produtos à base de tomate, chocolate, chimarrão.
- ▶ Ter cuidados especiais com medicamentos potencialmente “de risco”, como colinérgicos, teofilina, BCCs, alendronato de cálcio.
- ▶ Evitar deitar-se nas 2 horas posteriores às refeições.
- ▶ Evitar refeições copiosas.
- ▶ Suspender o fumo.
- ▶ Reduzir o peso corporal em obesos.

TRATAMENTO MEDICAMENTOSO

- Atualmente, as medicações de primeira escolha são os IBPs, que inibem a produção de ácido pelas células parietais do estômago, reduzindo a agressão do esôfago representada pelo ácido.
- O omeprazol é o IBP largamente empregado em nosso país, sendo fornecido gratuitamente pelo Ministério da Saúde para a população de baixa renda.
- Os IBPs em dose plena devem constituir o tratamento de escolha inicial por período de 4 a 8 semanas.
- Se o paciente não apresentar abolição dos sintomas, a dose deve ser dobrada, isto é, antes do desjejum e antes do jantar.



- Os antagonistas dos receptores H₂ da histamina são considerados medicações de segunda escolha.
 - ❑ Eles atuam bloqueando os receptores da histamina existentes nas células parietais, reduzindo a secreção de ácido.
 - ❑ Os mais usados são a ranitidina, a famotidina, a cimetidina e a nizatidina.
- Os procinéticos têm a propriedade de acelerar o esvaziamento gástrico, porém não exercem ação sobre os relaxamentos transitórios do EEI.
 - ❑ Os mais empregados são a metoclopramida e a domperidona, devendo ser indicados quando o componente de gastroparesia estiver presente.

TABELA 82.6 → Medicamentos empregados na doença do refluxo gastroesofágico

CLASSE	NOME GENÉRICO	DOSE-PADRÃO	EFEITOS COLATERAIS MAIS COMUNS
Antiácidos e alcalinos			
	Hidróxido de alumínio	Variável conforme apresentação	Constipação
	Hidróxido de magnésio	Variável conforme apresentação	Diarreia
Bloqueadores dos receptores H2 da histamina			Cefaleia, diarreia, tonturas, fadiga, confusão mental
	Cimetidina	400 mg 2x/dia	
	Ranitidina	150 mg 2x/dia	
	Famotidina	20 mg 2x/dia	
	Nizatidina	150 mg 2x/dia	
Inibidores da bomba de prótons			Cefaleia, diarreia, constipação, dor abdominal
	Omeprazol	20 mg antes do café	
	Pantoprazol	40 mg antes do café	
	Esomeprazol	40 mg antes do café	
	Lansoprazol	30 mg antes do café	
	Rabeprazol	20 mg antes do café	

Pró-cinéticos			
	Domperidona	10 mg antes das refeições	Sintomas extrapiramidais são raros
	Metoclopramida	10 mg antes das refeições	Agitação, sintomas extrapiramidais
	Bromoprida	10 mg antes das refeições	Semelhantes aos da metoclopramida
Inibidores de relaxamentos transitórios do esfíncter esofágico inferior (EEI)			
	Baclofeno	10 mg 3x/dia (iniciar dose noturna e após incluir as outras doses)	Tontura, sonolência, tremores

- As indicações do tratamento cirúrgico da DRGE não complicada são consideradas nas seguintes situações:
 - ❑ Pessoas que não respondem satisfatoriamente ao tratamento clínico, inclusive aquelas com manifestações atípicas, cujo refluxo foi devidamente comprovado.
 - ❑ Pessoas para as quais é exigido tratamento de manutenção com IBP, especialmente aquelas com menos de 40 anos de idade.
 - ❑ Casos em que não é possível a continuidade do tratamento de manutenção, por exemplo, na impossibilidade de arcar financeiramente com os custos do tratamento clínico em longo prazo.
- A cirurgia antirrefluxo pode ser convencional ou laparoscópica, sendo, ambas, operações de funduplicatura.
 - ❑ São equivalentes no que diz respeito ao desaparecimento dos sintomas.

Referências Bibliográficas

WINK, K.; ORNELAS, R.H. Síndrome dispéptica. In: GUSSO, Gustavo; LOPES, José M.C.; DIAS, Lêda C. (Orgs.). **Tratado de Medicina de Família e Comunidade: Princípios, Formação e Prática**. Porto Alegre: ARTMED, 2018, p. 2388. Cap. 166 e 167.

DUNCAN, B. B. et al. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em evidências. Disponível em: Minha Biblioteca, (5th edição). Grupo A, 2022. Cap. 82.



"Se você trata uma doença,
você pode ganhar ou perder.

Se você trata um paciente,
eu tenho certeza que você
sempre irá ganhar, não
importa o desfecho."

Patch Adams



Obrigada!